

# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



## **PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE CUALITATIVO**

**Calidad de Atención en Usuarios del Centro de Salud Belén,  
Ayacucho 2026**

Para optar el título profesional de:  
**LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

### **PRESENTADO POR:**

**Gresly Lucero PARIONA PALOMINO**

ORCID: 0009-0008-5421-9872

### **ASESOR:**

**Dr. Manglio AGUIRRE ANDRADE**

ORCID: 0000-0001-8234-567X

**AYACUCHO – PERÚ**

**2026**

## ÍNDICE GENERAL

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÍNDICE DE TABLAS</b>                                                                                                                   | <b>IV</b> |
| <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                                                                                       | <b>1</b>  |
| <b>1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                    | <b>4</b>  |
| 1.1. Contextualización del problema de investigación . . . . .                                                                            | 4         |
| 1.2. Formulación del Problema (Preguntas Norteadoras) . . . . .                                                                           | 6         |
| 1.2.1. Problema General (Pregunta Principal) . . . . .                                                                                    | 6         |
| 1.2.2. Problemas Específicos (Preguntas Específicas) . . . . .                                                                            | 6         |
| 1.3. Objetivos de la Investigación . . . . .                                                                                              | 7         |
| 1.3.1. Objetivo General . . . . .                                                                                                         | 7         |
| 1.3.2. Objetivos Específicos . . . . .                                                                                                    | 7         |
| 1.4. Viabilidad de la Investigación y Consideraciones Bioéticas . . . . .                                                                 | 8         |
| <b>2. MARCO CONTEXTUAL</b>                                                                                                                | <b>9</b>  |
| 2.1. Descripción geográfica, territorial y ambiental del área de estudio . . . . .                                                        | 9         |
| 2.2. Características demográficas y estructura poblacional . . . . .                                                                      | 10        |
| 2.3. Características socioculturales, lingüísticas y cosmovisión andina . . . . .                                                         | 11        |
| 2.4. Dinámica socioeconómica, vulnerabilidad y nivel de aseguramiento público                                                             | 12        |
| 2.5. Características sanitarias, cartera de servicios y capacidad resolutiva insti-<br>tucional . . . . .                                 | 13        |
| 2.6. Articulación dialéctica del escenario físico-social con las dimensiones<br>existenciales del usuario ( <i>Lebenswelt</i> ) . . . . . | 15        |
| <b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>                                                                                                         | <b>18</b> |
| <b>ANEXOS</b>                                                                                                                             | <b>20</b> |
| Anexo 1: Guía de Entrevista a Profundidad Fenomenológica . . . . .                                                                        | 20        |
| Anexo 2: Matriz de Consistencia Cualitativa . . . . .                                                                                     | 22        |
| Anexo 3: Formato de Juicio de Expertos . . . . .                                                                                          | 23        |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Anexo 4: Modelo de Consentimiento Informado . . . . . | 25 |
| Anexo 5: Carta de Asesoría Formal . . . . .           | 26 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|    |                                                                                                                                          |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Cartera de servicios asistenciales y talento humano del Centro de Salud Belén (I-3). . . . .                                             | 14 |
| 2. | Articulación dialéctica entre el contexto empírico de Belén y los existenciales de la calidad de atención ( <i>Lebenswelt</i> ). . . . . | 16 |
| 3. | Matriz de consistencia cualitativa fenomenológica (EN 486 - UNSCH). . . . .                                                              | 23 |
| 4. | Ficha técnica de validación cualitativa por juicio de expertos. . . . .                                                                  | 24 |

## INTRODUCCIÓN

La calidad de atención y el cuidado humano en el primer nivel de atención constituyen un imperativo ético y disciplinar indispensable para garantizar la dignidad de la persona y la consolidación de la cobertura sanitaria universal. En el marco de la investigación cualitativa bajo el diseño fenomenológico, la comprensión de este fenómeno no parte de abstracciones teóricas desvinculadas, sino de la inmersión vivencial y situada en los escenarios concretos donde acontece el encuentro interpersonal entre el profesional de salud y el usuario doliente. En estricta concordancia con la guía oficial para formular proyectos cualitativos de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), a cargo del Dr. Manglio Aguirre Andrade, la fundamentación del presente estudio se articula a través del recorrido inverso de contextualización (del ámbito específico al general) y el desarrollo riguroso de sus dimensiones justificatorias:

### 1. Contextualización de la problemática en tres niveles (Recorrido Inverso):

- **Nivel Local (Centro de Salud Belén, Ayacucho):** En el plano local y de manera estricta y exclusiva, la investigación se sitúa en el Centro de Salud Belén (Categoría I-3, Microred Huamanga), establecimiento cabecera que atiende a una población adscrita de 18,450 habitantes en el distrito de Ayacucho, a 2,760 metros sobre el nivel del mar. La realidad cotidiana del establecimiento está marcada por una profunda vulnerabilidad: el 68.2 % de los usuarios vive en condición de pobreza según el SISFOH, más del 94.5 % depende del Seguro Integral de Salud (SIS) y el 72 % posee bilingüismo activo quechua chanka-castellano. Para esta población, la calidad del cuidado no reside en la frialdad de un trámite clínico, sino en la necesidad vital de un trato digno, acogedor y respetuoso expresado en pautas andinas como el saludo afectuoso (*napaykuy*), la hospitalidad en la atención (*allin chaskiy*) y el respeto mutuo (*respetanakuy*). El estudio responde de forma vinculante a la **Prioridad Regional 10 de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030**, aprobada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho [1]: “*Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud*”.
- **Nivel Nacional (Perú):** En el contexto del país, la problemática local refleja las tensiones estructurales del sistema sanitario peruano, donde más del 78 % de las consultas ambulatorias recaen en el primer nivel de atención (categorías I-1 a I-4). La Política Nacional de Calidad en Salud del Ministerio de Salud (MINSA) [2] reconoce que la persistencia de barreras de trato interpersonal, la prisa protocolar

con consultas abreviadas de escasos minutos y la debilidad en la comunicación empática en lenguas originarias erosionan la confianza ciudadana y la adherencia a los tratamientos. Esta situación motivó al Estado peruano a priorizar la investigación en servicios sanitarios mediante la **Línea 10 de Investigación en Salud al 2030**: “*Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal*” (Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA) [3], con el fin de generar evidencia empírica directa para humanizar la atención asistencial.

- **Nivel Mundial (Internacional o Global):** En el plano internacional, los organismos rectores como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OCDE y el Banco Mundial [4] advierten que los sistemas sanitarios del mundo atraviesan una severa crisis de deshumanización asistencial provocada por la sobrecarga burocrática y el predominio de un paradigma biomédico tecnicista. Este enfoque reduce el acto clínico a procedimientos mecánicos de producción asistencial, invisibilizando la dimensión afectiva, el respeto al pudor somático y los determinantes socioculturales de la salud, lo que demanda con urgencia reorientar los servicios hacia un cuidado centrado en la persona y culturalmente seguro.

**2. Importancia y relevancia social del proyecto:** El estudio aborda un problema crítico de alta sensibilidad humana: la brecha latente entre los lineamientos institucionales y la vivencia sentida del usuario andino frente al cuidado de salud. Al develar los significados, frustraciones, silencios y experiencias de sosiego de las madres de familia en CRED, gestantes y personas adultas mayores del Centro de Salud Belén, se genera conocimiento de primera fuente para visibilizar la urgencia de una atención digna. Los beneficiarios directos serán los usuarios de la zona de Belén, quienes contarán con una vía científica para expresar sus demandas de respeto y buen trato; asimismo, los hallazgos beneficiarán al equipo de gestión del establecimiento, a la Red de Salud Huamanga y al colectivo profesional de enfermería.

**3. Finalidad o valor práctico:** A partir de sus objetivos, la investigación busca aportar evidencia empírica cualitativa para responder al problema de la despersonalización del acto de cuidado. Sus resultados permitirán proponer pautas concretas de mejora a las autoridades sanitarias competentes: el diseño de protocolos de acogida clínica humanizada con pertinencia lingüística en quechua chanka, la reorganización del tiempo de consulta para asegurar una escucha atenta y el fortalecimiento de la empatía en la relación enfermera-paciente en el Centro de Salud Belén.

**4. Valor teórico y tipología de la investigación:** Conforme a la tipología metodológica de la investigación científica, el estudio se clasifica como una **investigación básica o sustantiva**, con **nivel descriptivo-interpretativo** y un riguroso **diseño cualitativo fenomenológico** [5, 6]. Siguiendo las directrices epistemológicas de Edmund Husserl [7], Max van Manen [8] y Roberto Hernández-Sampieri [5], el proyecto llena un vacío crítico de conocimiento al contrastar la base teórica existente con la vivencia del poblador andino. Para ello, articula dialógicamente el modelo del **Proceso Interpersonal de Calidad en Salud de Avedis Donabedian** [9, 10] y la **Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson** [11] con los cuatro existenciales universales del *Lebenswelt*: relacionalidad (el encuentro humano y diálogo en quechua), temporalidad (tiempo y calma de la consulta), espacialidad (privacidad del consultorio) y corporalidad (respeto al pudor físico y alivio del dolor *nanay*).

**5. Valor metodológico:** En el ámbito metodológico, el proyecto aporta una guía de entrevista fenomenológica en profundidad semiestructurada bilingüe y una matriz de categorización temática cualitativa, centradas exclusivamente en la calidad del cuidado. Estos instrumentos y procedimientos se ajustan a los cuatro criterios de rigor cualitativo establecidos por Guba y Lincoln [12]: credibilidad, transferibilidad, consistencia y confirmabilidad, complementados con la técnica de triangulación múltiple de métodos y fuentes de información [13].

**6. Justificación institucional y bioética:** El protocolo cumple los estándares científicos de la cátedra de EN 486 (fundamentados en el rigor epistemológico de Mario Bunge [14]), respetando de forma irrestricta las normas bioéticas internacionales de la Declaración de Helsinki [15] y las pautas éticas del CIOMS [16], garantizando el consentimiento informado voluntario, la confidencialidad, el anonimato mediante códigos alfanuméricos y la no maleficencia para con los participantes.

## 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

### 1.1. Contextualización del problema de investigación

En el marco epistemológico de la investigación cualitativa y la guía oficial para formular proyectos con enfoque cualitativo de la Escuela Profesional de Enfermería (UNSCH), el planteamiento del problema adopta una **naturaleza puramente inductiva y fenomenológica**: no parte del aislamiento artificial de variables numéricas ni del contraste de hipótesis cerradas, sino del sentir, pensar y reflexionar sobre la trayectoria vivencial en el escenario natural donde acontece el encuentro del cuidado humano [5]. Como señalan Husserl [7] y van Manen [8], contextualizar un problema fenomenológico exige capturar la esencia, las emociones, los sentires corpóreos y los significados intersubjetivos que las personas otorgan a la calidad del cuidado recibido en el momento del acto asistencial.

Para tal fin, la metodología demanda un **contacto directo y vivencial con la realidad estudiada en su escenario cotidiano**. En el presente estudio, el origen de la indagación se sustenta en la observación reflexiva y la experiencia acumulada por la investigadora durante sus prácticas preprofesionales de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en los consultorios del Centro de Salud Belén, dialogando con los usuarios dolientes y presenciando sus incertidumbres y sentires.

En estricta observancia del canon metodológico del Dr. Manglio Aguirre Andrade y el protocolo cualitativo de referencia, la contextualización del problema de calidad de atención se articula a través del **recorrido inverso**, partiendo del ámbito específico hacia el general:

#### *1. Ámbito Local (Centro de Salud Belén, Ayacucho)*

En el plano local, el estudio se centra de manera estricta y exclusiva en el Centro de Salud Belén (Categoría I-3, Microred Huamanga), establecimiento cabecera que atiende a una población adscrita de 18,450 habitantes en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, a 2,760 metros sobre el nivel del mar. La investigación se focaliza exclusivamente en la dinámica asistencial de Belén, en vinculación directa con la **Prioridad Regional 10 de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030**, aprobada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho [1]: “*Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud*”.

En este escenario aflora una profunda distancia entre las normas programáticas institucionales y la vivencia sentida del usuario andino frente a la calidad del cuidado:

- **Vulnerabilidad socioeconómica y necesidad de contención afectiva:** El 68.2 % de la población usuaria se encuentra en situación de pobreza según el SISFOH y más del 94.5 % depende del Seguro Integral de Salud (SIS). Para estas familias, acudir a los consultorios de Belén representa un momento de vulnerabilidad extrema donde demandan no solo una prescripción médica o un procedimiento de enfermería, sino contención afectiva y comprensión empática frente a su precaria situación de vida.
- **Identidad lingüística y códigos andinos de calidad:** El 72.0 % de los usuarios presenta bilingüismo activo quechua chanka-castellano. Para esta población, la calidad de la atención no se concibe como un trámite administrativo frío, sino como un acto de reciprocidad y respeto que exige la acogida hospitalaria (*allin chaskiy*), el saludo cálido (*napaykuy*) y el respeto mutuo (*respetanakuy*), conforme a los hallazgos de Aguirre-Andrade y colaboradores [17].
- **La vivencia de la desatención y la prisa protocolar:** Cuando el personal sanitario —condicionado por la sobrecarga laboral o la digitación continua en el computador— no establece contacto visual, interrumpe el relato del paciente o muestra indiferencia ante el dolor físico (*nanay*), el usuario experimenta una profunda insatisfacción afectiva y desamparo, replegándose en el silencio defensivo (*upallay*). Asimismo, las consultas abreviadas de escasos minutos dejan en las madres de familia en CRED y en las personas adultas mayores dudas e incertidumbres no resueltas.

## 2. Ámbito Nacional (Perú)

En el ámbito nacional, la realidad observada en Belén refleja los nudos críticos del primer nivel de atención en el Perú (categorías I-1 a I-4), donde se concentra más del 78 % de las atenciones asistenciales de todo el país. La Política Nacional de Calidad en Salud del Ministerio de Salud [2] reconoce que la persistencia de barreras de trato interpersonal, frialdad burocrática y falta de pertinencia cultural debilita gravemente la capacidad resolutoria del sistema público. Esta situación motivó al Estado peruano a priorizar la investigación en servicios sanitarios a través de la **Línea 10 de Investigación en Salud al 2030**: “*Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal*” (Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA) [3], buscando dignificar la atención sanitaria en todos los establecimientos de atención primaria de la nación.

### 3. *Ámbito Mundial (Internacional o Global)*

A escala mundial, los sistemas de salud enfrentan una severa crisis de deshumanización asistencial caracterizada por la tecnificación desmedida del acto clínico y la sobrecarga burocrática en el primer nivel de atención, según lo advertido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OCDE y el Banco Mundial [4]. El predominio de un paradigma biomédico mecanicista ha reducido la evaluación de los servicios a meros indicadores cuantitativos de producción, invisibilizando la vivencia afectiva del paciente, el sufrimiento somático y los determinantes socioculturales de la salud. De acuerdo con Avedis Donabedian [9, 10] y Jean Watson [11], la calidad del cuidado no reside únicamente en la pericia instrumental de un procedimiento, sino medularmente en el proceso interpersonal: la calidez de la mirada, la capacidad de escucha compasiva, el respeto a la dignidad y la reciprocidad humanizada entre el profesional de salud y el ser cuidado.

El problema medular y objeto de estudio de la investigación radica, por consiguiente, en develar y comprender cómo los usuarios significan, valoran y experimentan la calidad de atención y el cuidado de enfermería en los consultorios del Centro de Salud Belén desde la profundidad de su mundo de la vida (*Lebenswelt*).

—

## 1.2. Formulación del Problema (Preguntas Norteadoras)

En coherencia con los preceptos del diseño fenomenológico de Hernández-Sampieri y Mendoza [5] y el marco teórico de la calidad interpersonal de Donabedian [10] y Watson [11], se formulan las preguntas norteadoras de la investigación:

### 1.2.1. *Problema General (Pregunta Principal)*

¿Cuál es el significado, estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto a la calidad de atención recibida en los servicios de salud del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026?

### 1.2.2. *Problemas Específicos (Preguntas Específicas)*

1. ¿Cómo experimentan los usuarios la **dimensión relacional (relación humana vivida / *Mitwelt*)** respecto a la calidez, empatía, escucha activa y comunicación intercultural en quechua chanka por parte del personal de salud?
2. ¿De qué manera vivencian los usuarios la **dimensión temporal (tiempo vivido / *Lebenszeit*)** respecto a la puntualidad, oportunidad y tiempo efectivo dedicado

por el profesional durante la consulta clínica?

3. ¿Cómo vivencian los usuarios la **dimensión espacial (espacio vivido / *Lebensraum*)** respecto a la privacidad, confidencialidad, comodidad física y dignidad ambiental de los consultorios?
4. ¿Cuáles son las vivencias de los usuarios vinculadas a la **dimensión corporal (cuerpo vivido / *Leib*)**, tales como el respeto al pudor físico, la contención del sufrimiento y el alivio del dolor (*nanay*)?
5. ¿Cuál es la **esencia compartida y las visiones divergentes** que configuran el significado atribuido por los usuarios a una atención de salud con calidad y calidez en el Centro de Salud Belén?

—

### 1.3. Objetivos de la Investigación

Guardando una estricta simetría biunívoca (1:1) con las preguntas norteadoras, se establecen los siguientes objetivos de investigación:

#### 1.3.1. *Objetivo General*

Comprender el significado, estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto a la calidad de atención recibida en el Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

#### 1.3.2. *Objetivos Específicos*

1. Comprender y analizar la experiencia de los usuarios en la **dimensión relacional (relación humana vivida / *Mitwelt*)** respecto a la calidez interpersonal, el trato digno y la comunicación en lengua quechua chanka brindada por el equipo de salud.
2. Explorar y comprender las vivencias de los usuarios en la **dimensión temporal (tiempo vivido / *Lebenszeit*)** en relación con la puntualidad, prontitud y duración efectiva del acto del cuidado asistencial en la consulta.
3. Describir y comprender la experiencia de los usuarios en la **dimensión espacial (espacio vivido / *Lebensraum*)** en cuanto al confort, reserva de la intimidad y privacidad física durante el cuidado en consultorios.
4. Identificar y comprender las vivencias de la **dimensión corporal (cuerpo vivido / *Leib*)**, analizando el respeto al pudor físico del paciente y la respuesta humanizada ante el dolor y sufrimiento somático (*nanay*).

5. Sintetizar la **estructura esencial y las divergencias fenomenológicas** que componen la calidad de atención de salud en el Centro de Salud Belén.

—

#### 1.4. Viabilidad de la Investigación y Consideraciones Bioéticas

El estudio es plenamente viable en términos temporales, técnicos y socioculturales, al contar con la apertura de los usuarios y el respaldo institucional de la cátedra de EN 486. La investigación se sujeta rigurosamente a los principios de la Declaración de Helsinki [15] y las pautas éticas internacionales del CIOMS [16]:

- **Autonomía y Consentimiento Informado:** Se aplicará un consentimiento informado bilingüe detallado, garantizando que la participación sea voluntaria y revocable en cualquier momento.
- **Confidencialidad y Anonimato:** Las grabaciones y transcripciones serán anonimizadas mediante códigos alfanuméricos confidenciales (INF-01 a INF-18).
- **No maleficencia y beneficencia:** La indagación no genera riesgos físicos ni psicológicos, y sus aportes servirán para promover mejoras directas en la humanización del cuidado en el Centro de Salud Belén.

## 2. MARCO CONTEXTUAL

En la investigación cualitativa bajo el diseño fenomenológico, el marco contextual no se reduce a una enumeración estática de datos cuantitativos ni a un inventario geográfico desvinculado; constituye la reconstrucción densa, profunda y holística del *ambiente natural* donde transcurre la vida cotidiana de las personas y donde se gesta el fenómeno estudiado [5, 6]. Para comprender la esencia de la experiencia vivida (*Lebenswelt*) de los usuarios respecto a la calidad de atención y el cuidado humano recibido en el Centro de Salud Belén, es indispensable caracterizar la atmósfera física, cultural, social y sanitaria que envuelve, condiciona y dota de sentido a sus sentires, expectativas, frustraciones y valoraciones intersubjetivas en el encuentro asistencial [1, 8, 10, 11].

### 2.1. Descripción geográfica, territorial y ambiental del área de estudio

La investigación se sitúa en el Centro de Salud Belén, establecimiento sanitario cabecera perteneciente a la Microred Huamanga de la Red de Salud Huamanga, adscrito a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho. El establecimiento se localiza en el emblemático e histórico barrio de Belén, en el sector céntrico-sur del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a una altitud oficial de 2,760 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas de emplazamiento corresponden a los 13°09'47" de Latitud Sur y 74°13'28" de Longitud Oeste.

El territorio bajo su responsabilidad sanitaria se asienta en la subcuenca del río Alameda, dentro de la cuenca principal del valle de Huamanga. Limita por el norte con el casco monumental y urbano central de la ciudad de Huamanga; por el sur con las urbanizaciones periurbanas del distrito de San Juan Bautista; por el este con las faldas del cerro Acuchimay y el distrito de Carmen Alto; y por el oeste con la prolongación de la avenida Mariscal Cáceres y el jirón Bellido. Su orografía presenta una topografía moderadamente accidentada, con calles estrechas, empinadas y trazados coloniales que imponen un esfuerzo físico considerable a los usuarios con movilidad reducida, gestantes y personas de la tercera edad que acuden a pie.

El clima del área es templado y seco durante las horas diurnas soleadas, con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 15 °C y 22 °C. No obstante, una característica meteorológica decisiva para la experiencia del usuario radica en la marcada oscilación térmica interdiurna: durante las madrugadas andinas (entre las 4:00 a.m. y las 6:30 a.m.), el termómetro desciende habitualmente a valores de entre 5 °C y 8 °C, llegando a extremos menores en la temporada seca y de heladas (junio a agosto). Asimismo, se presenta una temporada de precipitaciones pluviales intensas entre los meses de noviembre

y marzo. Esta condición ambiental no constituye un dato accesorio, sino un determinante corpóreo directo que condiciona la expectativa del cuidado: el usuario que arriba al establecimiento con frío penetrante, fatiga somática y dolor acumulado demanda una acogida asistencial empática y cálida que alivie su vulnerabilidad.

En cuanto a la conectividad y movilidad urbana, el establecimiento cuenta con acceso a través de vías pavimentadas (Jr. Bellido, Jr. Arequipa y Av. Mariscal Cáceres) y rutas de transporte público (líneas 1, 3, 7 y 12, además de mototaxis). A pesar de ello, las limitaciones económicas obligan a numerosas familias de sectores altos a realizar traslados peatonales de 20 a 40 minutos cargando niños en mantas tradicionales (*llicllas*). Esta exigencia física y ambiental predispone un estado de agotamiento al momento de ingresar a los consultorios, transformando la calidez del trato, la prontitud del saludo y la dignidad del espacio de espera en elementos determinantes de la calidad del cuidado.

## 2.2. Características demográficas y estructura poblacional

La jurisdicción sanitaria asignada al Centro de Salud Belén abarca una población diana proyectada de 18,450 habitantes según el Padrón Poblacional Oficial de la Red de Salud Huamanga (2025–2026). La pirámide poblacional se caracteriza por una base ensanchada en los primeros decenios de vida y una proporción creciente de personas adultas mayores, configurando un doble desafío asistencial de perfil materno-infantil y crónico-degenerativo. La distribución por etapas de vida es la siguiente:

- **Población Infantil (menores de 5 años):** Representa el 12.4% (2,288 niños), constituyendo el segmento con mayor intensidad de demanda en los consultorios preventivo-promocionales de Crecimiento y Desarrollo (CRED), tamizaje y tratamiento de anemia ferropénica, suplementación nutricional e inmunizaciones del esquema nacional regular.
- **Población Escolar y Adolescente (5 a 17 años):** Abarca el 19.6% (3,616 personas), demandantes de intervenciones de salud bucal, tamizaje visual, salud del escolar y orientación en salud sexual y reproductiva.
- **Población Joven y Adulta (18 a 59 años):** Constituye el 52.8% (9,742 personas), con un marcado predominio de mujeres en edad fértil (MEF) que acuden para control prenatal, despistaje de cáncer de cuello uterino, planificación familiar y atenciones médicas por patologías agudas.
- **Población Adulta Mayor (60 años a más):** Concentra el 15.2% (2,804 personas), un grupo en acelerado envejecimiento que presenta alta prevalencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, artrosis y secuelas osteomusculares, requiriendo un acompañamiento asistencial continuo, trato digno y calidez

humana preferencial.

Desde la mirada fenomenológica, resalta el fenómeno de la **feminización de la demanda matutina**: más del 70% de los usuarios que concurren a las salas de espera son mujeres. Se trata de madres de familia que acuden al cuidado y vigilancia de la salud de sus hijos menores, mujeres gestantes en controles prenatales y mujeres cuidadoras que asisten a adultos mayores dependientes. Esta dinámica impone sobre la mujer andina una sobrecarga cotidiana de roles, donde la calidad del cuidado recibida en enfermería y medicina —medida en paciencia explicativa, respeto a su dignidad y calidez en el trato— resulta decisiva para afianzar su confianza en los servicios del Estado.

### 2.3. Características socioculturales, lingüísticas y cosmovisión andina

El entorno comunitario de Belén se distingue por una singular riqueza identitaria y una densa trama de sociabilidad popular. Históricamente, el barrio de Belén ha sido cuna de ilustres artesanos populares de Huamanga, reconocidos internacionalmente por el arte del retablo ayacuchano, la imaginería religiosa en yeso y el tallado tradicional en piedra de Huamanga. En este espacio geográfico coexisten familias tradicionales residentes desde hace generaciones con oleadas de población migrante provenientes de las zonas rurales y provincias del centro-sur ayacuchano (Víctor Fajardo, Cangallo y Vilcas Huamán), muchas de ellas asentadas a raíz de la violencia sociopolítica de las décadas pasadas.

En el plano lingüístico, el **72 % de la población usuaria es bilingüe activa en quechua chanka y castellano**. En las generaciones de adultos mayores y en mujeres migrantes de sectores periféricos, el quechua constituye la lengua materna predominante y el vehículo exclusivo para verbalizar el sufrimiento corpóreo y anímico. Para la cosmovisión andina huamanguina, los padecimientos no son meras disfunciones biológicas aisladas, sino alteraciones del equilibrio integral del ser humano con su entorno, expresadas en nociones complejas como el dolor visceral (*nanay*), el estado de enfermedad integral (*onqoy*), la tristeza y aflicción acumulada (*llakikuy*), el enfriamiento del cuerpo (*chiriyay*) o los desórdenes espirituales derivados del espanto o susto (*mancharisqa*).

Las pautas de sociabilidad comunitaria exigen de manera indeclinable la observancia de códigos éticos y de cortesía tradicionales basados en el respeto mutuo (*respetanakuy*), el saludo formal y afectuoso (*napaykuy*) y la acogida hospitalaria (*allin chaskiy*) [17]. Cuando el personal de salud —frecuentemente hispanohablante monolingüe o condicionado por la prisa protocolar— prescinde del saludo, evita el contacto visual, interrumpe el relato del usuario o emplea un léxico excesivamente tecnicista, se produce un violento quiebre comunicativo. El usuario andino interpreta esta conducta como desdén, frialdad burocrática, soberbia institucional o discriminación clasista y étnica, replegándose en el

silencio (*upallay*) y perdiendo la confianza en el sistema asistencial.

En cuanto al nivel de instrucción, el 48 % de los jefes de familia cuenta con educación secundaria completa, un 26 % posee secundaria incompleta o primaria, y un 8 % (concentrado en adultos mayores) registra analfabetismo formal o funcional. Esta realidad representa un desafío crítico para la alfabetización en salud, pues muchos usuarios no logran descifrar las recetas médicas escritas, los calendarios de citas o la señalética institucional de los consultorios, dependiendo enteramente de la orientación verbal empática que el profesional de enfermería pueda suministrarle.

#### 2.4. Dinámica socioeconómica, vulnerabilidad y nivel de aseguramiento público

La actividad socioeconómica de los hogares usuarios del Centro de Salud Belén se inserta de manera mayoritaria en el régimen de la economía popular informal y de subsistencia diaria. La Población Económicamente Activa (PEA) labora preponderantemente en el comercio ambulatorio de verduras, frutas y alimentos preparados en el Mercado Central de Belén y su concurrida feria sabatina; en el transporte menor mediante la conducción de mototaxis; en faenas eventuales de construcción civil (albañilería y peonaje); en talleres artesanales independientes; y en el trabajo doméstico no remunerado o remunerado por jornada.

De acuerdo con los registros del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el **68.2 % de las familias del ámbito de influencia se encuentra clasificada en situación de pobreza y pobreza extrema**. En coherencia con este perfil de precariedad material, el **94.5 % de la población usuaria se encuentra afiliada al régimen subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS)**.

Esta dependencia casi total del aseguramiento público estatal confiere una trascendencia vital a la gratuidad y suficiencia del servicio. Los usuarios acuden al centro asistencial bajo la certeza legítima de que el Estado proveerá tanto el acto clínico humanizado como los medicamentos necesarios para su recuperación. Cuando la farmacia del establecimiento incurre en roturas de stock o desabastecimiento de medicamentos esenciales (como antibióticos de primera línea, antipiréticos, micronutrientes para la anemia o fármacos antihipertensivos), se suscita una crisis devastadora en la economía doméstica: el usuario se ve conminado a realizar un **gasto de bolsillo imprevisto** en las boticas y farmacias comerciales privadas que proliferan en los alrededores del centro de salud.

Esta vulnerabilidad socioeconómica agudiza la sensibilidad del usuario frente a la calidad del trato interpersonal: cuando el paciente percibe indiferencia, respuestas displicentes o discriminación por su condición humilde al momento de solicitar atención o retirar sus medicinas, la vivencia de calidad se fractura profundamente, generando

sentimientos de desamparo frente a la precariedad del sistema público.

### **2.5. Características sanitarias, cartera de servicios y capacidad resolutiva institucional**

El Centro de Salud Belén se encuentra formalmente categorizado como un establecimiento de salud del primer nivel de atención de nivel **I-3** (sin internamiento hospitalario), desempeñando un papel neurálgico como cabecera de microred asistencial. Su misión operativa consiste en brindar atención integral ambulatoria, promocional, preventiva y de recuperación básica a la población vulnerable de su ámbito territorial y jurisdiccional.

A continuación se detalla la oferta prestacional y la distribución del talento humano asistencial disponible en el establecimiento:

**Tabla 1:** Cartera de servicios asistenciales y talento humano del Centro de Salud Belén (I-3).

| <b>Cartera de Servicios</b>         | <b>Actividades Asistenciales Principales</b>                                                                                    | <b>Turno</b>   | <b>Personal Asignado</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Medicina General                    | Consulta ambulatoria, diagnóstico clínico, prescripción médica y atención de morbilidades agudas y crónicas.                    | Mañana / Tarde | 04 Médicos Cirujanos     |
| Enfermería (CRED e Inmunizaciones)  | Control del crecimiento y desarrollo del niño, tamizaje de anemia, vacunación del esquema regular y consejería nutricional.     | Mañana / Tarde | 06 Lic. en Enfermería    |
| Enfermería (TBC y No Transmisibles) | Control de tuberculosis (PCT), administración de tratamiento DOTS, tamizaje de hipertensión arterial y diabetes mellitus.       | Mañana         | 02 Lic. en Enfermería    |
| Obstetricia (Salud Reproductiva)    | Control prenatal, psicoprofilaxis obstétrica, monitoreo fetal básico, planificación familiar y tamizaje de cáncer ginecológico. | Mañana / Tarde | 04 Lic. en Obstetricia   |

El perfil epidemiológico de la demanda ambulatoria está hegemonizado por las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), parasitosis intestinal, anemia por deficiencia de hierro en niños menores de 36 meses, infecciones del tracto urinario (ITU) en mujeres en edad fértil y gestantes, lumbalgias mecánicas derivadas del trabajo físico, y patologías crónicas no transmisibles (hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2) en adultos mayores.

No obstante su relevancia estratégica, el establecimiento enfrenta una serie de **nudos críticos institucionales y barreras operativas** que inciden directamente en la subjetividad del usuario:

1. **Sobrecarga asistencial y presión por rendimiento horario (tiempo de consulta abreviado):** El elevado número de usuarios asignados por turno y la exigencia de metas de producción asistencial reducen drásticamente los minutos dedicados a cada consulta clínica ambulatoria (frecuentemente de 10 a 15 minutos). Esta premura temporal condiciona un ritmo de atención apresurado que limita la profundización en el diálogo clínico, restringe el espacio para la consejería de enfermería y dificulta la acogida empática de las dudas y temores del paciente.
2. **Limitaciones arquitectónicas y hacinamiento espacial:** El centro de salud funciona en un inmueble cuya infraestructura original ha sido sucesivamente adaptada, presentando pasillos estrechos, salas de espera techadas pero con escaso aislamiento térmico y bancas metálicas insuficientes. La tabiquería provisional entre consultorios adolece de aislamiento acústico, lo que provoca la filtración de conversaciones clínicas y quebranta el derecho a la privacidad e intimidad corporal y emocional de los pacientes.
3. **Inestabilidad laboral y sobrecarga burocrática:** Una fracción considerable del personal profesional y técnico se encuentra bajo regímenes de contratación temporal transitoria (CAS), lo que origina una continua rotación de profesionales que interrumpe la continuidad del vínculo afectivo con los pacientes de la comunidad. A ello se suma la sobrecarga de digitación en los sistemas informáticos (HIS-MINSA y formato FUA-SIS), la cual absorbe gran parte del tiempo de consulta, obligando al profesional a interactuar con la pantalla del computador en detrimento del contacto visual con el usuario.

## 2.6. Articulación dialéctica del escenario físico-social con las dimensiones existenciales del usuario (*Lebenswelt*)

En concordancia con los postulados epistemológicos de Max van Manen [8], John Creswell [6] y Roberto Hernández-Sampieri [5], articulados con el modelo del

Proceso Interpersonal de Avedis Donabedian [10] y la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson [11], el mundo de la vida (*Lebenswelt*) de los usuarios se manifiesta a través de cuatro existenciales universales donde se construye el significado de la calidad de atención:

**Tabla 2:** Articulación dialéctica entre el contexto empírico de Belén y los existenciales de la calidad de atención (*Lebenswelt*).

| <b>Dimensión Existencial (<i>Lebenswelt</i>)</b>                  | <b>Manifestación Empírica en el Contexto de Belén</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Significado Vivencial de la Calidad Construido por el Usuario</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relacionalidad</b><br>( <i>Relación vivida con los otros</i> ) | Encuentro intersubjetivo entre el usuario quechua-mestizo vulnerable y el personal sanitario; presencia del saludo cordial ( <i>napaykuy</i> ) o su omisión; mirada a los ojos frente a la mirada fija en el monitor; paciencia explicativa o respuestas cortantes. | La calidad se define en la dignidad del trato interpersonal: el usuario busca acogida humana ( <i>allin chaskiy</i> ), respeto mutuo ( <i>respetanakuy</i> ) y comprensión en su propia lengua originaria. La calidez del cuidado de enfermería transforma la vulnerabilidad en alivio, confianza y gratitud. |
| <b>Temporalidad</b><br>( <i>Tiempo vivido</i> )                   | Puntualidad en el inicio de la atención; duración efectiva del contacto clínico en consultorio; lapsos de espera frente a una consulta médica de apenas 10 a 15 minutos; ritmo pausado para escuchar dudas.                                                         | Vivencia de la desvalorización del tiempo del paciente frente a la prisa protocolar. Una atención de calidad se experimenta cuando el profesional no muestra apuro, escucha sin interrumpir y dedica tiempo suficiente para clarificar el tratamiento.                                                        |
| <b>Espacialidad</b><br>( <i>Espacio vivido</i> )                  | Consultorios con tabiquería delgada que deja filtrar conversaciones clínicas; pasadizos congestionados; puertas entreabiertas durante la exploración médica; comodidad y limpieza del consultorio.                                                                  | Sensación de exposición pública o resguardo de la intimidad. La calidad espacial exige consultorios cerrados, confortables y seguros donde el usuario sienta absoluta reserva y confidencialidad respecto a sus padecimientos íntimos.                                                                        |
| <b>Corporalidad</b><br>( <i>Cuerpo vivido</i> )                   | Delicadeza y respeto al pudor corporal al desvestirse o ser examinado; tacto suave en inyecciones y curaciones de enfermería; respuesta afectuosa ante el llanto del niño o los dolores articulares del anciano.                                                    | El cuerpo doliente ( <i>nanay</i> ) no es un objeto mecánico de intervención, sino el asiento directo de la vulnerabilidad ontológica. La calidad del cuidado reside en la delicadeza física, la calidez manual y la empatía somática que reconforta el cuerpo enfermo ( <i>onqoy</i> ).                      |

Esta articulación multidimensional confirma que, para el usuario del Centro de Salud Belén, la “calidad de atención” trasciende ampliamente los parámetros gerenciales o el abastecimiento instrumental; constituye una experiencia existencial totalizante donde la relación interpersonal, el tiempo dedicado, el espacio íntimo y el respeto al cuerpo configuran la esencia del cuidado digno y humanizado en el sistema público de salud.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Referencias

- [1] Dirección Regional de Salud de Ayacucho. Prioridades Regionales de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030. Ayacucho: DIRESA Ayacucho; 2025. Disponible en: <https://repositorio.ins.gob.pe/>
- [2] Ministerio de Salud del Perú. Sistema de Gestión de la Calidad en Salud: Documento Técnico. Resolución Ministerial N° 519-2006/MINSA. Lima: MINSA; 2006. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/255018-519-2006-minsa>
- [3] Ministerio de Salud del Perú. Líneas Nacionales de Investigación en Salud al 2030. Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA. Lima: MINSA / Instituto Nacional de Salud; 2025. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales>
- [4] World Health Organization, OECD, The World Bank. Delivering quality health services: a global imperative for universal health coverage. Geneva: World Health Organization; 2018. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/272465>
- [5] Hernández-Sampieri R, Mendoza CP. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana Editores; 2018. Disponible en: <https://isbnsearch.org/isbn/9781456260965>
- [6] Creswell JW. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications; 2013. Disponible en: <https://isbnsearch.org/isbn/9781412995306>
- [7] Husserl E. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Gaos J, traductor. México D.F.: Fondo de Cultura Económica; 1949. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=224213>
- [8] van Manen M. Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Albany (NY): State University of New York Press / Routledge; 1990. doi: <https://doi.org/10.4324/9781315421056>
- [9] Donabedian A. Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Vol. 1: The Definition of Quality and Approaches to its Assessment. Ann Arbor (MI): Health Administration Press; 1980. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7409848/>

- [10] Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. 1966. *Milbank Q.* 2005;83(4):691-729. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00397.x>. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1464018/>
- [11] Watson J. *Nursing: The philosophy and science of caring*. Revised ed. Boulder (CO): University Press of Colorado; 2008. Disponible en: <https://archive.org/details/details/nursingphilosoph0000wats>
- [12] Lincoln YS, Guba EG. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills (CA): SAGE Publications; 1985. Disponible en: <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/naturalistic-inquiry-1-842>
- [13] Okuda Benavides M, Gómez-Restrepo C. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Rev Colomb Psiquiatr.* 2005;34(1):118-24. Disponible en: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-74502005000100008](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000100008)
- [14] Bunge M. *La ciencia, su método y su filosofía*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana / Penguin Random House; 2014. Disponible en: [https://books.google.com.pe/books/about/La\\_ciencia\\_su\\_m%C3%A9todo\\_y\\_su\\_filosof%C3%ADa.html?id=lq8rDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.com.pe/books/about/La_ciencia_su_m%C3%A9todo_y_su_filosof%C3%ADa.html?id=lq8rDwAAQBAJ&redir_esc=y)
- [15] Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Fortaleza (Brasil): AMM; 2013. Disponible en: <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones>
- [16] Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). *Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos*. 4ta ed. Ginebra: CIOMS / OPS; 2016. Disponible en: <https://cioms.ch/publications/product/pautas-eticas-internacionales-para-la-investigacion-relacionada-con-la-salud>
- [17] Aguirre-Andrade M, Tenorio-Acosta I, Rivas-Díaz L, Valenzuela-Oré F, Sánchez-Simbrón M, Quino-Huamaní F. Promoción de salud y nivel de salubridad de las familias, en comunidades del Distrito de Cangallo, Ayacucho 2020. *Rev Investig Salud.* 2020;14(2):45-58. Disponible en: <http://repositorio.unsch.edu.pe/>

## ANEXOS

### Anexo 1: Guía de Entrevista a Profundidad Fenomenológica Semiestructurada Bilingüe

**Título de la investigación:** Calidad de atención en usuarios del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

**Investigadora:** Gresly Lucero Pariona Palomino | **Asesor:** Dr. Manglio Aguirre Andrade.

**Propósito cualitativo:** Explorar, describir y comprender la esencia de la experiencia vivida (*vivencias*) por el usuario respecto a la calidad de atención, el trato humano y el cuidado en el Centro de Salud Belén.

#### I. Ficha de Caracterización del Informante Clave (Muestra de Casos Tipo):

- Código del participante: \_\_\_\_\_ | Fecha: \_\_\_\_\_ | Hora inicio/fin: \_\_\_\_\_
- Edad: \_\_\_\_ años | Sexo: [ ☐ ] Femenino [ ☐ ] Masculino
- Procedencia (Barrio / Sector): \_\_\_\_\_ | Tiempo viviendo en Huamanga: \_\_\_\_\_
- Idioma materno: [ ☐ ] Quechua chanka [ ☐ ] Castellano [ ☐ ] Bilingüe
- Nivel de instrucción: [ ☐ ] Sin instrucción [ ☐ ] Primaria [ ☐ ] Secundaria [ ☐ ] Superior
- Ocupación principal: \_\_\_\_\_ | Tipo de seguro: [ ☐ ] SIS subsidiado [ ☐ ] Otro
- Servicio asistencial donde recibió atención hoy: [ ☐ ] Medicina [ ☐ ] CRED [ ☐ ] Inmunizaciones [ ☐ ] Obstetricia [ ☐ ] Odontología

#### II. Preguntas de Apertura y Clima de Confianza (*Rapport* y *Napaykuy*):

1. ¿Podría relatarme qué motivo de salud le motivó a acudir hoy al Centro de Salud Belén y cómo se sentía anímicamente antes de ingresar al consultorio?  
*En quechua chanka:* ¿Imataq qamta sasachasunki mamay/taytay, imaynam sonqoyki kachkarqa doctorman manaraq yaykuchkaspayki?
2. ¿Es la primera vez que se atiende en este establecimiento o suele venir frecuentemente a este servicio?  
*En quechua chanka:* ¿Qallariykutichu kay Centro de Saludpi atendichikunki, icha sapa kutichu hamunki?

### III. Preguntas por Dimensiones Existenciales Fenomenológicas (van Manen y Sampieri):

#### ■ Dimensión Existencial 1: Temporalidad (El tiempo vivido en la consulta)

3. ¿Cómo experimentó usted el tiempo que el personal de salud (médico, enfermera) le dedicó en la consulta? ¿Sintió que la atención fue apresurada y con prisa, o que le brindaron el tiempo y la calma necesaria para escuchar sus dolencias y explicarle con claridad su tratamiento?

*En quechua chanka:* ¿Imaynatam sientekurqanki doctor o enfermera atiendesunaykipaq tiempo qosusqaykiwan? ¿Utqayllachu qawasurqanki icha pacienciawanchu llapa tapukuyniykikunata uyarirqasunki hinaspa hampiytapas allinta willasurqanki?

#### ■ Dimensión Existencial 2: Espacialidad (El espacio vivido y privacidad en consultorio)

4. ¿Cómo experimentó el ambiente del consultorio durante su atención? ¿Sintió que el espacio le brindó la debida privacidad, tranquilidad y reserva para conversar sobre sus problemas de salud y ser examinado(a) sin que personas ajenas observen o escuchen?

*En quechua chanka:* ¿Imaynatam consultorio ukuta sienterqanki? ¿Chaypi hawka, chuya hinaspa secretollapichu sientekurqanki doctorwan onqoyniykimanta rimanaykipaq, mana pipas uyaripayasuspayki?

#### ■ Dimensión Existencial 3: Corporalidad (El cuerpo vivido durante el acto de cuidado)

5. Al momento de ser examinado(a) físicamente o recibir una atención (curación, inyección, control de CRED o triaje), ¿cómo sintió que el personal de salud trató su cuerpo? ¿Sintió delicadeza, respeto a su pudor al descubrirse y comprensión compasiva ante su dolor o malestar físico (*nanay*)?

*En quechua chanka:* ¿Doctorkuna o enfermerakuna cuerpoykita examinantinku o hampiptinku, imaynam sientekurqanki? ¿Llampu makillawanchu, pinqakuyniykita respetaspachu hinaspa nanayniykita llakipayaspachu cuidarasunki?

#### ■ Dimensión Existencial 4: Relacionalidad (La relación humana vivida e intersubjetividad)

6. ¿Cómo fue el trato interpersonal y el encuentro humano con el personal de salud (médico, enfermera)? ¿Sintió un trato digno, acogedor y empático con contacto visual? ¿Le recibieron con un saludo cordial (*napaykuy*, *allin chaskiy*) y le hablaron con paciencia en su lengua originaria (que-

chua chanka)?

*En quechua chanka:* ¿Imaynam runa kayninkuwan chaskisurqanki doctor o enfermera? ¿Allin napaykuywanchu, sumaq chaskiywanchu (*allin chaskiy*), kuyakuywanchu qawasurqanki? ¿Runasimipichu respetowan rimapayasurqanki?

■ **Dimensión 5: Síntesis de la Esencia de la Calidad y Cuidado Humano**

7. Al reflexionar sobre la atención recibida hoy, ¿qué significa para usted que un servicio de salud brinde auténtica calidad y calidez humana, y qué aspectos considera fundamentales para que el cuidado en el Centro de Salud Belén sea verdaderamente digno?

*En quechua chanka:* ¿Tukuy kaykunata yuyaripa, imataq qampaq allin calidadwan kuyapayaywan hampikuyqa? ¿Imatataq doctorwan enfermera ruranman llapa runa sonqonpi allin atendisqa hinaspa respetasqa sientekunanpaq?

**Anexo 2: Matriz de Consistencia Fenomenológica Cualitativa**

**Título:** CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026.

**Tabla 3:** Matriz de consistencia cualitativa fenomenológica (EN 486 - UNSCH).

| Problema Fenomenológico                                                                                                                                                                        | Objetivos Cualitativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preguntas Norteadoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dimensiones Existenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metodología Cualitativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>General:</b><br>¿Cuál es el significado, la estructura y la esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto a la calidad de atención en el Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026? | <b>General:</b><br>Comprender el significado, estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto a la calidad de atención en el Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.<br><br><b>Específicos:</b><br>1. Analizar la calidez relacional y el diálogo en quechua chanka.<br>2. Comprender la oportunidad y tiempo efectivo dedicado en consulta.<br>3. Describir la privacidad y confidencialidad en consultorio.<br>4. Identificar el respeto al pudor físico y alivio del dolor.<br>5. Sintetizar la esencia y divergencias de la calidad asistencial. | 1. ¿Cómo experimentan el trato digno, empatía y quechua chanka?<br><br>2. ¿De qué manera vivencian la duración y calma en la consulta?<br><br>3. ¿Cómo vivencian la reserva y privacidad en el consultorio?<br><br>4. ¿Cómo viven el respeto a su pudor somático y dolor?<br><br>5. ¿Cuál es la esencia y visiones divergentes de la calidad? | <b>Categoría Central:</b><br>Calidad de Atención de Salud (Donabedian y Watson).<br><br><b>Existenciales del Lebenswelt:</b><br>• D1: Relacionalidad ( <i>Mitwelt</i> )<br>• D2: Temporalidad ( <i>Lebenszeit</i> )<br>• D3: Espacialidad ( <i>Lebensraum</i> )<br>• D4: Corporalidad ( <i>Leib</i> )<br>• D5: Esencia y Divergencias | <b>Paradigma y Enfoque:</b><br>Interpretativo-fenomenológico, naturalista (Husserl, van Manen, Sampieri).<br><br><b>Muestra e Informantes:</b><br>Casos tipo no probabilístico. Criterio de saturación teórica (12 a 18 informantes clave).<br><br><b>Técnicas e Instrumentos:</b><br>Entrevista fenomenológica en profundidad bilingüe, observación reflexiva y notas de campo.<br><br><b>Análisis y Rigor:</b><br>Método de Colaizzi / van Manen con ATLAS.ti v9. Criterios de rigor de Guba y Lincoln. |

### Anexo 3: Formato de Validación Cualitativa por Juicio de Expertos

#### I. ASPECTOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): \_\_\_\_\_
- 1.2. Grado académico del experto: \_\_\_\_\_
- 1.3. Profesión del experto: \_\_\_\_\_
- 1.4. Institución donde labora: \_\_\_\_\_
- 1.5. Cargo que desempeña: \_\_\_\_\_
- 1.6. Denominación del instrumento: Guía de entrevista a profundidad fenomenológica semiestructurada bilingüe.
- 1.7. Autora del instrumento: Gresly Lucero Pariona Palomino.

1.8. Título de la tesis: Calidad de atención en usuarios del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

## II. CRITERIOS DE RIGOR Y VALIDACIÓN CUALITATIVA (SAMPIERI, 2014):

| Criterios                      | Indicadores de Evaluación Cualitativa                                                                     | Sí  | No  | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
| 1. Claridad dialógica          | Preguntas formuladas con lenguaje coloquial, abierto y comprensible para el usuario andino.               | [ ] | [ ] |               |
| 2. Pertinencia lingüística     | Preguntas en quechua chan-ka gramaticalmente naturales, afectuosas y culturalmente pertinentes.           | [ ] | [ ] |               |
| 3. Consistencia fenomenológica | Articulación rigurosa con los cuatro existenciales del mundo de la vida (van Manen y Sampieri).           | [ ] | [ ] |               |
| 4. Coherencia vivencial        | Correspondencia simétrica entre las preguntas y la captura de la esencia y las divergencias vivenciales.  | [ ] | [ ] |               |
| 5. Relevancia del cuidado      | Explora estrictamente la interacción humana, los sentires corporales y la dignidad del cuidado.           | [ ] | [ ] |               |
| 6. Capacidad de saturación     | Capacidad inductora de las preguntas para suscitar relatos densos y alcanzar la saturación de categorías. | [ ] | [ ] |               |

**Tabla 4:** Ficha técnica de validación cualitativa por juicio de expertos.

### Observaciones generales:

Ayacucho, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ del 2026.

---

### FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

#### Anexo 4: Consentimiento Informado para Participantes Informantes Clave

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, domiciliado en \_\_\_\_\_, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga.

He sido invitado(a) a participar de manera libre y voluntaria en la investigación titulada: **“CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026”**, desarrollada por la bachiller Gresly Lucero Pariona Palomino, bajo la asesoría del Dr. Manglio Aguirre Andrade de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH).

Declaro que se me han brindado las siguientes garantías de forma clara en mi idioma materno:

1. Mi participación consistirá en compartir mis experiencias y sentires personales mediante una entrevista dialógica.
2. La sesión será grabada únicamente en audio con fines de transcripción fidedigna.
3. Mi identidad se mantendrá en estricta reserva y anonimato mediante el empleo de un código alfanumérico confidencial.
4. Mi participación es 100 % voluntaria; puedo suspender la entrevista o retirarme del estudio en el momento que desee sin que ello perjudique en absoluto la atención médica que recibo en el establecimiento.

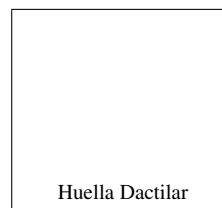
En señal de plena conformidad, suscribo el presente documento y estampo mi huella dactilar.

Ayacucho, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2026.

---

**Firma del Participante Informante**

DNI N°: \_\_\_\_\_



### **Anexo 5: Carta de Aceptación y Asesoría Formal del Proyecto de Tesis**

Ayacucho, 15 de enero del 2026.

**Dr. Alejandro Yarlequé Mujica**

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

#### **Asunto: Aceptación y Compromiso de Asesoría de Proyecto de Tesis Cualitativo**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho para hacer de su conocimiento que he aceptado formalmente brindar la asesoría académica y metodológica al Proyecto de Tesis con enfoque cualitativo y diseño fenomenológico titulado:

**“CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN,  
AYACUCHO 2026”**

presentado por la egresada **Gresly Lucero Pariona Palomino**, para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería, en el marco de la cátedra de Proyecto de Investigación en Salud (EN 486).

Dicha labor de asesoría se desarrollará garantizando el más riguroso estándar científico y bioético durante las fases de formulación, dictamen ético, inmersión en campo, análisis fenomenológico, redacción del informe final y sustentación pública.

Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi especial estima personal.

Atentamente,

---

**Dr. Manglio Aguirre Andrade**

Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud – UNSCH  
ORCID: 0000-0001-8234-567X | DNI: \_\_\_\_\_